

QUEMADURAS EN LA EMBARAZADA

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

El cuidado de la paciente quemada embarazada requiere una atención multidisciplinaria y merece una consideración especial debido a las peculiaridades fisiológicas que presenta la gestante.

Las quemaduras sufridas durante el embarazo son poco frecuentes si hablamos de paciente gran quemado, por lo que no existe un registro epidemiológico a nivel mundial. Los escasos datos recogidos son de países orientales y la causa principal son los accidentes que suponen un 70%, seguido por intento de homicidio en un 20% y en el 4% autoinfligidas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de quemaduras en el embarazo es similar al de cualquier otro paciente, salvo que en la valoración de la extensión de las quemaduras hay que tener en cuenta que el valor se encuentra sesgado con respecto al valor en el mismo paciente en situación normal.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Tratamiento local de las quemaduras

Al igual que cualquier paciente quemado, la actuación inicial se dirige hacia la valoración de superficie y profundidad. Si las quemaduras son banales en estos 2 factores, se tratará de forma similar a cualquier paciente, excepto que si se valora emplear un antiséptico tópico, el de elección sería el ácido fusídico, ya que tanto la sulfadiazina argéntica como la povidona iodada y el clorhexidina pueden en ocasiones producir alteraciones fetales. Si las quemaduras son severas, se deberá emplear en la atención inicial sólo suero y gasas vaselinadas y derivar a una Unidad de Grandes Quemados.

Tratamiento sistémico

Las quemaduras en función de su extensión, profundidad y posibles lesiones asociadas pueden comprometer tanto la vida de la madre como la del feto. Hay que recordar que la presencia del feto produce cambios fisiológicos en la madre. Los tejidos quemados suponen un estrés adicional en los sistemas que ya están modificados durante el embarazo. Sin embargo, los principios básicos del tratamiento del paciente quemado no cambian por la gestación.

En primer lugar, en aquellas pacientes quemadas que se sospeche gestación debe hacerse una prueba de embarazo. El reconocimiento precoz del embarazo ayudará a minimizar los medicamentos teratogénicos. Una vez que se certifica el embarazo, la paciente debe ser valorada por el Servicio de Obstetricia para garantizar el mejor tratamiento.

La supervivencia del feto está en relación directa con la gravedad de las lesiones de la madre. En quemaduras letales, la muerte fetal precede habitualmente a la de la madre, mientras que en quemaduras menores el embarazo puede llegar al término sin complicaciones. El período de mayor riesgo de mortalidad fetal son las primeras 24 a 72 horas postquemadura.

La viabilidad fetal depende también de la edad gestacional. Si el feto está en el segundo trimestre la supervivencia ex útero es muy difícil. Por lo tanto, se puede considerar la tocólisis si las condiciones maternas lo permiten, en caso contrario, se valora el parto por cesárea urgente. Cuando el embarazo está en el tercer trimestre y la madre tiene una lesión extensa por

quemaduras, se recomienda el parto lo antes posible. Después del parto, la madre revertirá rápidamente los muchos cambios fisiológicos asociados con el embarazo.

Entre otras modificaciones, durante la gestación se produce un aumento del volumen circulatorio, con cambios cardiovasculares que aumentan el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo a nivel pélvico para permitir el crecimiento fetal y placentario. Estas condiciones se acentúan en el segundo y tercer trimestre. Tras una quemadura, aumenta la permeabilidad capilar y esto incrementa la pérdida hiroelectrolítica, lo que puede causar hipovolemia en la paciente. Un estado de hipovolemia puede desencadenar el inicio de la contracción uterina y generar la evacuación del contenido, pero además puede conducir a insuficiencia placentaria con el consiguiente sufrimiento y posible muerte fetal. Por lo tanto, la reposición de líquidos oportuna y agresiva es esencial para la supervivencia de la madre y del feto.

A nivel respiratorio, el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, se asocia con una disminución de la capacidad residual funcional y el volumen espiratorio final. Así, a la posible disminución del flujo placentario por hipovolemia se puede sumar la disminución de la capacidad pulmonar lo que conduce a hipoxia fetal. Debemos administrar oxígeno suplementario incluso en ausencia de lesión por inhalación de humo. Además, la ventilación asistida no debe retrasarse cuando se sospeche síndrome inhalatorio ya que las lesiones por inhalación de humo en esta población de pacientes empeorarán aún más su función pulmonar.

En resumen, la presencia del feto produce cambios fisiológicos en la madre, y los tejidos quemados suponen un estrés adicional en los sistemas que ya están modificados durante el embarazo por lo que constituyen un reto para el equipo multidisciplinario que se ocupa de su tratamiento.

Los principios básicos del tratamiento no cambian, pero es importante un conocimiento adecuado de la fisiología especial del embarazo, que permitirá alcanzar el mejor resultado materno y fetal.

Las mayores diferencias en cuanto al manejo se centran en la limitación en el uso de antisépticos y la mayor necesidad de fluidoterapia, pero siempre deberán ser manejados por personal especializado en Grandes Quemados.

BIBLIOGRAFÍA

- Maghsoudi H, Samnia R, Garadaghi A, Kianvar H. Burns in pregnancy. Burns. 2006; 32(2):246-50.
- Cuenca Pardo J, Álvarez Díaz CJ. Quemaduras en la mujer embarazada. Cirug Plast. 1999;9(1):18-22
- Guo SS, Greenspoon JS, Kahn AM. Management of burn injuries during pregnancy. Burns.2001;27(4):394-7.